

acompanhamento () consulta

NS 22231696414 755

CLAYTON BATISTA MARTINELLI

IDADE: 40 anos PESO: 136 ALTURA: 1,80 PROFISSÃO: Prefeitura Cacaporã.

SINTOMAS: Acorda com sono; + concentração; sonolência diurna;

QUEIXAS: Dificuldade iniciar sono; força.

MEDICAMENTOS: Benicar, Ablok, Simbi (amildade); Renuvarkahra; Glifag.

MÉDICO: Dra Flávia / Internet → Adou Sonelino / Dr. Genh Figueiredo

EXERCÍCIO FÍSICO: 0

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 0 ALMOÇO: 5 LANCHE: 0 JANTAR: 5

HORA QUE DORME: 03h HORA QUE ACORDA: 07h30' 10h30'

COCHILO (X)SIM ()NÃO DORME ACOMPANHADO ()SIM (X)NÃO ()EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X)SIM ()NÃO X NA SEMANA ()NÃO é cabado / dorme na sala

FUMO (X)SIM ()MAÇO/DIA ()NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: pouco esporádico.

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: 0

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IV IAH: 5,4 e/ev SPO2: 90%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N)NASAL (N)AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Sim.

COMORBIDADE: (N)RESPIRATÓRIA (S)ENDÓCRINA (S)CARDÍACA

(N)ORTOPÉDICA (N)NEUROLÓGICA (N)OUTROS

24/01 Biology. sem CPAP

avaliado → auto 4 a 12 cmH₂O não suíte (2)

31/01 P = 11,8 cmH₂O

Dorme D.D.

24 IAH = 12.1

m. de uso: 8h35'

apneia no início do sono → a P_i = 6 cmH₂O

16/02 P = 11.7 cmH₂O = 12.5 (95%)

24 m. de uso = 8h42'

IAH = 5.4 e/ev

Fuga = 10.4 l/min.

Bem adaptado.

P_i = 7 cmH₂O.

boa

15/03 P = 12 cmH₂O

↑ a pressão p/ 12.6 cmH₂O

24 IAH = 4.4 e/ev

m. de uso: 8h50'

Fuga = 0.0

boa

24/05 P = 12 cmH₂O

24 IAH = 2.9 e/ev

m. de uso = 8h55'

Fuga = 0.0 lpm

boa.

CONSULTA

19/07

24

P = 12,6 cmH₂O

IAH = 1,7 e/h

m. de uso: 8h 15m

fuga P95: 15 e/m

Bem adaptado
Siquixas

Natasha

07/10

24

P = 12,6 cmH₂O

IAH = 2,5 e/h

M. de uso: 8h 10'

Fuga = 0,4 lpm.

Jua

28/10

24

P = 12,6 cmH₂O

IAH = 2,0 e/h

M. de uso: 9h 16'

fuga = 0,0 lpm.

(21d e de uso constante.)

Jua.

27/01

25

P = 12,6 cmH₂O

IAH = 2,3 e/h

m. de uso: 9h

fuga = 14,9 lpm.

29d. constante.

Jua cláudio

05/05

25

P = 12,6 cmH₂O

IAH = 3,0

m. de uso: 10h

fuga = 21,4 lpm.

Exerc. 3x por semana.

Jua cláudio

Nome: CLAYTON BATISTA MARTINELI

Data de Nascimento: 12-5-1983

IMC: 31,48

Sexo: Masculino

Data do exame: 15-08-2018

Peso: 102 kg

Altura: 1,80 m

Médico: DRA. FLAVIA K. S. OLIVEIRA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 15-08-2018, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 557,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 185,0 e 291,0 minutos. O tempo total de sono foi de 163,5, eficiência de 29,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,7%; estágio N2: 61,2%; estágio N3: 28,4%; sono REM: 6,7%. O índice de despertares foi de 4,6/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 5,1, sendo elas 2 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 12 hipopnéias. A SpO2 média foi de 95% e mínima de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 63 - 69 bpm e NREM de 58 - 89 bpm. O paciente roncou.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (2), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem dos estágios N2 e N3 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 5,1/hora;
4. não houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=90%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (13,6/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

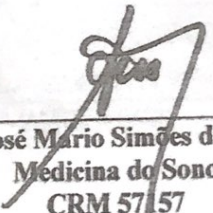
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau leve.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157